جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : صفاء الصباحى ابراهيم نصار
المحافظة : المنوفيه **الحي / المدينة :** شبين الكوم **العنوان :** --
رقم البطاقة : 26711241700188 **رقم التليفون :** 01061562130 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 09-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 24-11-1967 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام رنين علي الفقرات العنقيه والصدريه بالصبغه [11112] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: صفاء الصباحي ابراهيم نصار
National ID: 26711241700188

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي MRI cervical and thoracic spine with contrast

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: الأستاذه / صفاء الصباحى ابراهيم نصار	Request No.	: 131535
Patient No.	: 26711241700188	Request Date	: 09/12/2021
Path No.	: 3043/21	Verification Date	: 13/12/2021
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 54 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Lt breast mass

Nature of the specimen:
Tru cut biopsy

Gross Examination:
Four gray white tissue cores up to 1.5cm, totally submitted.

Microscopic examination:
- Histological type: IDC
- Grade II
- Angioinvasion: no
- Ductal carcinoma in situ: no

Diagnosis:
Lt breast mass, tru cut biopsy:
Invaive duct carcinoma GII
For (ER, PR, Her2, Ki67)

Prof.Gamal AbdelAty
Dr.Rana Fathy

Verified by :
iman gouda

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: صفاء الصباحى ابراهيم نصار **MR. :** 7173	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

Post-mastectomy left breast cancer, clinical stage CT3, no metastasis. Histology: IDC grade 2, ER 6/8, PR 6/8, HER2-negative. Ki-67 10%. The patient underwent left whole-breast irradiation (WLE) with a boost to the tumor bed (YPT2, YPN0/2). Post-operative chemotherapy was completed (4 cycles). A port was placed in the left femoral vein in March 2022 for subsequent systemic therapy. The patient is currently receiving Femara (letrozole) and Zometa (zoledronic acid) for bone-protective therapy.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **dina makram**

يعتمد ,

مبادرة رئيس الجمهورية
لتحسين صحة المرأة المصرية

MDT FORM

28/7/2022

4

Name	[illegible]	MRN	[illegible]
		ID	[illegible]
Age	53.	Phone	[illegible]
Menopausal status		marital status	
OCP		Family history	
Co morbidity			

Clinical Data

Bx:

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
6/8	6/8	—	10%

Sonomammography :

Mets Workup:

R L

T N M
3 0

Recommendations:

- MRI Breast → Honey
- CESM → unifocal 5.1 x 4 x 4.8 cm (9cm from anchor muscles)
  21 2022
- Recall Smr of Hand → Dn → Size of mass. Core Dmesen 4 x 2 cm) without dist of cleavage plane muscles
  For CG.n. → Remote Complete Study

MDT OUTCOME & PLAN

[illegible]

28/7/2022 → CESM → PR
for Lt BCS + SLN B (+ wire localization)

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
SIGNATURE			

CC IVICA

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

MDT FORM

Name	[illegible]
Age	53y.
MRN	[illegible]
ID	
Co morbidity	DM



Tel: 01066385194

1

Clinical Data

Bx: H IDC grade II

SM: Lt breast mass at 11 o'clock 2.4 x 2.3 cm BIRAD 4B

IHC:
ER: +ve 6/8
PR: +ve 6/8
HerY: -ve
KiY: 10%

Mets Workup:
CT → bilateral tiny subpleural Pulm. nodule for follow
↳ D3 & D1 lytic lesion
Bone scan → free

cl T_3 N_0 M_0

COMMENT: =4cm, free

MRI → 6/12/22

SM → unifocal mass, No axill. LN (11/2021)

MDT OUTCOME & PLAN

26-2-2022 → - postmenop. + luminal A ⇒ Mostly Mets

* For ⇒ - MRI Dorsal spine
- CESM + target axilla US
- Meanwhile start A.I + zometa

4 ReMDT

if Mets ⇒ Continue A.I

- if not mets ⇒ surgery acc to CESM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]



DMS
صفاء
Alsabahi



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

Patient's Name:	**Safaa Al-Sabbahi Ibrahim Nassar**
Date:	**2026-09-06**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Post left CBS a, routine follow up study.

Findings:

Right breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b).
- **Retraorealarfocal assymtery with round calcifications.**
- **No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.**
- **UOQ small intrammary Ln .**
- **Ultrasound demonstrated sattaionary benign lesion measuring 8 mm .**
- **10 oclock ,zone 3 small benign intramammay LN .**
- **Normal skin/nipple/areola complex.**
- **Non-specific axillary LNs.**

Left breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- UIQ architectural distortion with no speculations, masses, asymmetry , or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated UIQ area of parenchymal disruption underneath the operative scar with no solid , cystic lesions or fluid collections.
- Thickened skin reaching 5 mm and coarsen trabeculae.
- Normal nipple/areola complex.
- Clear left axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Conclusion:-

- ***Right breast (BIRADS 2): Beniong findings***
- ***Left breast (BIRADS 2): Post-therapeutic sequalae.***

Recommendation:-

For annual follow up.

Prof.MONA ZAKY

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
هيئة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Safaa Al Sabbahy Ibrahim Nassar	Date : 17/07/2022
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 54 Year(s)
Medical ID: 5179/2021	Pat. ID: 15178

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Known case of left breast cancer on therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left UIQ spiculated dense mass with surgical clip seen within
- Right breast retro areolar distortion with benign calcifications.

Complementary ultrasound :

- Left 10 O'clock irregular hypoechoic solid mass , measured about 4.5 x 2 cm
- Right breast retroaroelar distortion covering an area measures about 1.3 x 3 cm with oval shaped isoechoic lesion within measures 0.7 cm in diameter.
- Right UOQ intra mammary lymph node pathologically proven benign.
- Nonspecific bilateral axillary LNs.

Opinion:

- Left UIQ pathologically proven carcinoma showing partial therapeutic response (BIRADS6)
- Right breast retroareolar distortion pathologically proven inflammatory process for prober medical treatment and follow up (BIRADS3)

Yours truly

Signature Dr. Aya Deabes

17/07/2022 3:50 PM